# Cirrosis, vía biliar, páncreas y diarrea

FISIOPATOLOGIA · Clase 39 · del hígado cicatrizado a la piedra, la enzima que se activa sola y el agua que no se absorbe

## 1 · HEPATITIS VIRALES Y ALCOHOL

**Hepatitis virales** F24
A y E: fecal-oral, solo agudas; B, C y D pueden cronificar

**Hepatitis D** F27
virus defectivo: necesita el HBsAg del VHB para replicarse

si es A, un ejemplo es el

**Brote en una residencia** F28
ictericia, orina oscura y TGP muy alta: hepatitis A, que no cronifica

entre los que cronifican está el

también puede cronificar el

otra causa de hepatitis es el

necesita el HBsAg del

**Hepatitis B** F16 · F26
puede curarse, fulminar, cronificar, dar cirrosis o hepatocarcinoma; HBsAg > 6 meses = crónica o portador

**Hepatitis C** F25
sobre todo por sangre; cronifica en 70-85 % (VHB: 5-10 % de adultos, 90 % de neonatos)

**Hepatitis alcohólica** F29
hepatocitos muertos y células inflamatorias; AST/ALT > 2, casi siempre < 500 UI/L

al cronificar mantiene la

al cronificar mantiene la

si se sostiene causa

*sube la presión: causa*

**Necrosis crónica** F15
hepatitis B o C, alcohol o desnutrición severa mantienen la muerte de hepatocitos

## 2 · CIRROSIS: LA CICATRIZ DEL HÍGADO

**Célula estrellada** F17
activada (miofibroblasto) entre sinusoide y hepatocito: deposita colágeno

al depositar colágeno produce

**Cirrosis** F10 · F11
fibrosis nodular difusa y crónica: nódulos de regeneración rodeados de cicatriz

*activa a la*

se confirma con

se evalúa con las

cierra el sinusoide: causa

**Biopsia** F3
confirma el diagnóstico: nódulos rodeados de fibrosis

**Pruebas hepáticas** F22
fabrica: albúmina, TP; excreta: bilirrubina, FA, GGT; libera al dañarse: TGO, TGP, LDH

**Resistencia sinusoidal alta**
los sinusoides pierden sus fenestraciones y la sangre de la porta no pasa

deja establecida la

su baja síntesis revela

Cirrosis confirmada: se busca la causa y se vigilan la porta y la función hepática

**Falla sintética**
baja la albúmina y se alarga el TP

## 3 · HIPERTENSIÓN PORTAL Y COMPLICACIONES

**Hipertensión portal** F18
la porta cerrada produce ascitis, várices y esplenomegalia

abre vías que causan

congestiona y causa

**Circulación colateral**
várices, hemorroides y cabeza de medusa; el bazo crece con hiperesplenismo

**Ascitis** F12
líquido en el abdomen: porta congestionada, albúmina baja y volumen efectivo bajo

*no depura y sube el*

*baja la albúmina y favorece*

la más grave son las

baja el volumen y activa el

puede infectarse: causa

**Várices esofágicas** F23
sangran y dan hematemesis

**SRAA** F19
el riñón interpreta falta de volumen: la aldosterona retiene sodio y agua

**Peritonitis bacteriana espontánea** F4
infección del líquido ascítico: es espontánea, no «secundaria»

sangran: hemorragia y

si persiste causa

lleva a sepsis y

**Síndrome hepatorrenal** F21
riñón sano en falla funcional; orina pobre en sodio

**Amoníaco** F20
el hígado cirrótico no lo depura: sube y produce asterixis y encefalopatía

lleva a

produce encefalopatía y

Cirrosis descompensada: hemorragia, sepsis o coma hepático pueden ser mortales

## 4 · PIEDRAS EN LA VÍA BILIAR

**Factores de riesgo** F31
mujer (4 a 1), estrógenos, obesidad, edad y pérdida rápida de peso

favorecen la

**Formación del cálculo** F30 · F14
bilis sobresaturada de colesterol, vesícula que vacía mal y moco que atrapa cristales; 80 % son de colesterol

si tapa el cístico causa

**Cálculo en el cístico** F32
tapa la salida, la mucosa se irrita y la pared se engruesa

irrita la pared y causa

**Colecistitis calculosa** F7 · F34
dolor > 6 h, fiebre y Murphy; sin ictericia

si el cálculo migra al colédoco

**Cálculo en el colédoco** F33 · F35
bilis infectada detrás: tríada de Charcot (fiebre, dolor, ictericia) = colangitis

*al afectar el páncreas participa en la*

puede dar

**Complicaciones del cálculo** F2
colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis, cirrosis biliar; la esclerosante es autoinmune

termina en

Ictericia obstructiva con riesgo de sepsis (ver lámina 31)

## 5 · PANCREATITIS: AUTODIGESTIÓN

**Causas** F9 · F36
litiasis biliar y alcohol: cerca del 80 % («piedras y copas»); el cáncer de vesícula no obstruye el conducto pancreático

activa el

**Tripsinógeno activado** F37
se activa dentro del páncreas y las enzimas lo digieren (autodigestión)

la lipasa produce

irrita el peritoneo y causa

libera enzimas y causa

se detecta con la

**Necrosis grasa** F5 · F38
la lipasa libera ácidos grasos que forman jabones con el calcio: baja el calcio, no el potasio

**Lipasa** F13 · F40
sube a las pocas horas; > 3 veces lo normal confirma; más sensible y específica que la amilasa

**Íleo segmentado** F40
las enzimas irritan el peritoneo y paralizan el asa vecina

**Respuesta sistémica** F39
enzimas y citocinas en la sangre: shock, SDRA, necrosis tubular y CID

confirma una

con hipocalcemia puede llevar a

agrava el cuadro de

termina en

Pancreatitis grave con falla multiorgánica

## 6 · DIARREA: MÁS AGUA EN LAS HECES

**Diarrea** F41
más agua en las heces: > 200 g/día o > 3 deposiciones líquidas al día

si una sustancia atrae agua es

si está en el delgado, da

si está en el colon, da

si una toxina activa el AMPc es

**Osmótica** F42
una sustancia no absorbida atrae agua; cesa con el ayuno

**Secretora** F1 · F42 · F43
toxina o VIP activan la adenilato ciclasa: sube el AMPc y el Cl- arrastra agua a la luz; no cede con el ayuno

**Delgado** F6 · F45
pocas evacuaciones y de mucho volumen

**Colon** F45
evacuaciones frecuentes y pequeñas, con moco, pus o sangre

pierde agua y electrolitos: causa

pierde agua y electrolitos: causa

por el gran volumen causa

con moco, pus o sangre orienta a

**Pérdidas** F44
agua, Na+, K+ y bicarbonato: deshidratación, hipopotasemia y acidosis metabólica

si no se repone termina en

Deshidratación: reponer agua y electrolitos

## 7 · ESTREÑIMIENTO

**Constipación crónica** F46
< 3 evacuaciones por semana, heces duras o esfuerzo

una causa orgánica es el

al evacuar duro puede causar

**Hipotiroidismo** F47
enlentece el tránsito del colon

**Fisura anal** F48
dolor al evacuar y sangre roja en las heces

enlentece el colon y termina en

su dolor provoca

la forma funcional es la

**Retención voluntaria** F8 · F48
el dolor al evacuar hace retener; las heces se endurecen; no es una obstrucción mecánica

cierra el

Círculo vicioso: más dolor, más retención, heces más duras

concepto · ejemplo · mecanismo · causa · diagnóstico · signo · complicación · desenlace · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Literatura (Robbins, Guyton) y wiki del vault: sin clase del docente · litiasis 4 a 1 de la Clase 36 (Dr. Sotito)